

Ви лікар приймального відділення дитячої клінічної лікарні.

До Вас звернулася мати дитини 5-ти років зі скаргами на підвищення температури у дитини до 37,5°C, біль у животі, імперативні позиви до сечовипускання, неутримання сечі, неприємний запах сечі.

Із анамнеза відомо, що дитина захворіла 4 дні тому після переохолодження.

Анамнез життя: росла та розвивалася відповідно віку. Рідко хворів на ГРВІ, бронхіт.

Об'єктивно: стан дитини середньої тяжкості: самопочуття дитини не порушено. Шкіра звичайного кольору, чиста. При аускультатії – дихання везикулярне. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС 100 уд/хв. Живіт м'який, при пальпації помірно болісний у надлобковій ділянці. Симптом Пастернацького негативний. Часте, болісне сечовипускання малими порціями.

Показники	Дані пацієнта	Нормативні значення
Гемоглобін, г/л	120	110-140
Еритроцити, 10 ¹² /л	4,0	3,7-4,9
Кольоровий показник, од	0,9	0,8-1,0
Тромбоцити, 10 ⁹ /л	230	150 – 400
Лейкоцити, 10 ⁹ /л	10,8	5-10
Паличкоядерні нейтрофіли, %	1	0,5-5
Сегментоядерні нейтрофіли, %	50	25-60
Лімфоцити, %	42	26-60
Еозинофіли, %	4	1-5
Моноцити, %	3	2-10
ШОЕ, мм/год	10	4-12

Клінічний аналіз сечі:

Колір – блідо жовтий

Прозорість - каламутна

pH – слабо кисла

Питома вага – 1018 (норма 1015-1025)

Білок – 0,013 г/л (норма до 0,033 г/л)

Глюкоза – відсутня (норма - відсутня)

Лейкоцити – 25-30 в полі зору (норма 3-4 п/з)

Еритроцити – 1-2 в полі зору (норма 1-2 п/з)

Рівень бактеріурії(сеча, взята із середньої порції)

3-4

-> 10 КУО/мл (норма – бактеріурія відсутня)

Біохімічний аналіз крові: СРП - негативний

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановити контакт з пацієнтом та батьками/опікунами (привітатись, представитися, позначити свою роль).	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр.

	Коректне розташування лікар-пацієнт	
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного обстеження дитини	Сказати Чи дасте Ви свою згоду на проведення клінічного обстеження Вашої дитини (Будемо вважати що згода отримана)
2.Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнта (зі слів батьків/опікунів)	Сказати: Скільки років дитині? Очікувана відповідь: 5 років Сказати: Які скарги у дитини? Очікувана відповідь: скарги на підвищення температури до 37,5°C, біль у животі, імперативні позиви до сечовипускання, неутримання сечі, неприємний запах сечі
2.2	Анамнез хвороби	Сказати: «Коли дитина захворіла, які особливості захворювання?» Очікувана відповідь: захворіла 4 дні тому після переохолодження.
2.3	Анамнез життя	На які захворювання дитина хворіла? Алергія? Травми/операції? Щеплення? Спадковість?
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавички	Виконати/сказати Будемо вважати, що руки оброблені
3.2	Загальний стан	Сказати:стан дитини середньо тяжкий. Самопочуття не порушено
3.3	Аускультация легень та серця. Пальпація живота.	Сказати:При аускультції – дихання везикулярне. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС 100 уд/хв. Живіт м'який, при пальпації помірно болісний у надлобковій ділянці. Симптом Пастернацького негативний. Часте, болісне сечовипускання малими порціями
4.Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного та біохімічного аналізу крові	Сказати: незначна лейкоцитурія, СРП негативний
4.2	Визначити результат клінічного та бактеріологічного аналізу сечі	Сказати:незначна лейкоцитурія, бактеріурія, сліди білка.
4.3	Визначити провідний синдром	Сказати:дизурічний та больовий.
4.4	Встановити клінічний діагноз	Інфекція сечовивідних шляхів.
5.Визначення тактики ведення та лікування		

5	Призначити подальшу тактику ведення пацієнта	Сказати:можливо дообстеження дитини на амбулаторно-поліклінічному етапі з призначенням антибактеріальної терапії – пер ос цефалексін 50 мг на кг на добу у 2 прийоми 10 днів.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати: раціональне харчування, підтримання достатнього водного балансу організму, профілактика переохолодження.
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнта/батьків/опекунів про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати:Ви повинні знати про можливі ускладнення інфекцій сечовивідних Шляхів – пієлонефрит.